

出院摘要结构化包

生成时间：2026-05-29 19:27:11

出院摘要结构化包

患者姓名：陈萍忠

性别：女

年龄：68岁

一、住院期间BPSD类型

- 拒绝进食
- 拒绝配合照护
- 情绪躁动

二、住院期间BPSD频次

(未提供具体频次数据, 留空)

三、有效干预记录

- 精神行为干预
- 对症支持治疗
- 非药物干预 (包括陪伴交流、结合跳舞喜好引导参与温和活动)

四、无效干预记录

(无相关信息, 留空)

五、药物调整项

- 启动氨氯地平片 5mg 每日一次 (qd) 用于控制血压
- 启动阿托伐他汀钙片 20mg 每晚一次 (qn) 用于调节血脂

六、出院NPI评分

16分 (中度精神行为异常)

七、出院ADL评分

(未提供, 留空)

八、触发因素清单

- 情绪刺激

九、高风险提示

- 跌倒风险（需环境适老化改造）
- 心血管事件风险（高血压、高血脂、心电图T波改变）
- BPSD症状复发风险（NPI评分仍达16分）
- 家属照护负荷过重可能导致的用药安全风险（既往有自行加药史）

十、出院医嘱

1. 规律服用降压药（氨氯地平片 5mg qd）及调脂药（阿托伐他汀钙片 20mg qn），每日晨起监测血压并记录；
2. 避免剧烈活动及情绪刺激，落实跌倒防护措施，家中及照护机构需清除地面障碍物、安装扶手；
3. 出院后3个月复查心电图，若出现情绪躁动、意识异常等表现应及时就诊；
4. 照护中重点关注认知相关行为，持续开展非药物干预，多陪伴交流，结合其喜爱跳舞的特点引导参与温和活动，以缓解BPSD症状；
5. 关注家属照护焦虑情绪，必要时提供心理支持，并指导家属掌握基础照护技巧及BPSD应对方法。

十一、返院承接建议

- 返院后延续住院期间有效的非药物干预策略，尤其利用老人对跳舞的兴趣设计温和活动；
- 确保降压及调脂药物按时、按量服用，建立服药监督机制；
- 照护环境须完成适老化改造（移除障碍物、加装扶手等）；
- 密切观察情绪与行为变化，发现躁动或意识异常立即联系医疗团队；
- 为家属提供持续的心理支持与照护技能培训，预防照护倦怠与不当干预。

十二、家属配合要求

- 增加陪伴与沟通频率，采用温和、耐心的方式引导照护；
- 学习并实践BPSD症状的